# FICHA INICIAL DO PROJETO

*Unidade 1: Problema, projeto e dados — Aula 1 — Entrega obrigatória*

07 de outubro de 2026

**Turma: Técnico de Ciência de Dados**

**Data de entrega:** 07 /10 / 2026

## 1. Ficha Inicial do Projeto

Esta seção destina-se à definição preliminar do escopo de análise da equipe, contextualizando a transição do sistema operacional (Login System) para a camada de visualização analítica (Dashboard de Análise de Dados).

**1. Nome do projeto** Vigilância epidemiológica

**2. Integrantes do grupo (até 5 alunos):**

1. Daniela Freitas

2. Eliane Pereira

3. Gustavo Duarte

**3. Tema geral da análise:** Saúde pública

**4. Problema identificado:**

As epizootias em primatas são um alerta precoce da febre amarela, mas é difícil enxergar onde e quando elas se concentram ao longo dos anos.

**5. Pergunta principal que o projeto pretende responder:**

Como o número de epizootias em PNH mudou ao longo dos anos e quais regiões concentraram os picos?

**6. Justificativa (por que esse problema é relevante e merece investigação):**

A febre amarela é grave e prevenível por vacina. Saber onde e quando os alertas aparecem ajuda a orientar vigilância e vacinação.

**7. Público-alvo (quem poderá utilizar ou se beneficiar dos resultados):**

Estudantes, profissionais e gestores de saúde e o público em geral.

**8. Informações e variáveis necessárias para conduzir a análise:**

Local (UF e município), data, ano, mês e período de monitoramento de cada ocorrência.

**9. Possível fonte de dados primária:**

**Base de epizootias em PNH (fa_epizpnh_1994-2026.csv), Ministério da Saúde.**

**10. Link de acesso à fonte dos dados:**

https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/ckan.saude.gov.br/Febre+Amarela/fa_epizpnh_1994-2026.csv

## 2. Pesquisa Inicial de Dados (Anexo Obrigatório)

O preenchimento deste anexo comprova a viabilidade técnica da proposta mediante a identificação prévia de conjuntos de dados públicos consolidados e acessíveis.

**1. Nome da base de dados:** fa_epizpnh_1994-2026.csv

**2. Instituição ou órgão responsável:** Ministério da Saúde

**3. Link direto do repositório/arquivo:** https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/ckan.saude.gov.br/Febre+Amarela/fa_epizpnh_1994-2026.csv

**4. Formato de disponibilização do arquivo (CSV, XLSX, JSON etc.): C**SV, separador ";", codificação Latin-1

**5. Período temporal coberto pelos dados:** 2000 a 2026 (datas completas de 2002 a mai/2026)

**6. Quantidade aproximada de registros (linhas):** 2.637

**7. Principais colunas (variáveis de interesse identificadas no conjunto):**

**MACRORREG_OCOR, UF_OCOR, MUN_OCOR, DATA_OCOR, MES_OCOR, ANO_OCOR, MONITORAMENTO_OCOR**

**8. Três perguntas analíticas passíveis de resposta com esta base:**

a) Quais regiões, estados e municípios concentram mais epizootias em PNH?

b) Como o número de epizootias notificadas mudou ao longo dos anos e dos períodos de monitoramento?

c) Em quais meses do ano as epizootias são mais frequentes?

**9. Pergunta analítica prioritária escolhida pela equipe:**

**Como o número de epizootias em primatas não humanos mudou ao longo dos anos e quais regiões concentraram os picos?**

**10. Possíveis indicadores (métricas, taxas ou contagens a serem calculadas):**

**Total de epizootias: 2.637; Municípios com ocorrência: 633; Estados com ocorrência: 17; Ano de pico: 2017 (869); Região com mais registros: Sudeste (54,3%); Estado líder: SP (35,7%); Município líder: São Paulo (115); Mês mais frequente: janeiro**

**11. Possíveis gráficos para compor o Dashboard (barras, linhas, dispersão etc.):**

**Linhas por ano, para responder a pergunta principal.**

**Barras empilhadas por ano e macrorregião.**

**Barras ou setores por macrorregião (são só 5 categorias).**

**Ranking dos 10 municípios e das UFs.**

**Barras por mês, para a sazonalidade.**

**Tabela por período de monitoramento.**

**Filtros por UF e ano.**

## 3. Diretrizes e Lembretes para a Equipe

**Orientações Técnicas para Execução da Atividade:**

1. Não escolha o tema da pesquisa antes de verificar tecnicamente a existência e disponibilidade real de dados públicos abertos.

2. Priorize estritamente repositórios governamentais e fontes oficiais: dados.gov.br, IBGE, Portal da Transparência, Dados Abertos do MEC, IPEAData e Dados Abertos da Saúde (DATASUS).

3. Registre detalhadamente a proveniência dos dados: instituição de origem, autoria, período de referência e aplicação no projeto.

4. Ao término da Aula 1, a equipe deve ter estabelecido formalmente: um problema de pesquisa delimitado, uma pergunta norteadora, uma base de dados viável e o esboço inicial do Dashboard de Análise de Dados.

Documento registrado e protocolado em 07 de outubro de 2026.